

Protokół *terapii GAD*

Mapa 12–16 sesji. Trzy główne nurty: CBT (Dugas), MCT (Wells), ACT (Roemer). Wiesz, co Cię czeka — i co po Tobie.

CZAS: 15 min Przegląd na start terapii

ŹRÓDŁO: Dugas i wsp. (2007); Wells (2009); Roemer & Orsillo (2009)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj **trzy najczęściej stosowane protokoły** (sekcja 01): CBT klasyczne (Dugas), MCT (Wells), ACT (Roemer & Orsillo). Zobacz **fazy terapii** wspólne dla wszystkich (sekcja 02). Wypełnij **swój plan startu** (sekcja 03): który protokół, kiedy, z kim. To *nie* zastępuje konsultacji ze specjalistą — to *mapa*, która pozwala wejść do gabinetu z konkretnymi pytaniami.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pacjent rozpoczynający terapię zwykle *nie wie*, co go czeka. Nie wie, ile sesji, w jakim kierunku, jakie narzędzia. To buduje lęk antycypacyjny i blokuje zaangażowanie. **Mapa terapii** — choć orientacyjna — daje poczucie kontroli i jasności. Pozwala też świadomie wybrać nurt: jedne protokoły są *bardziej* behawioralne (CBT klasyczne), inne pracują z metaprzekonaniami (MCT), jeszcze inne z akceptacją i wartościami (ACT). *Wszystkie* mają porównywalną skuteczność (Cuijpers i wsp., 2014), więc liczy się **dopasowanie do pacjenta**.

01 📋 Trzy główne protokoły

CBT KLASYCZNE (DUGAS)

12–16 sesji · model IU

Centrum: nietolerancja niepewności + zachowania szukające pewności.

Narzędzia: psychoedukacja, samomonitorowanie, restrukturyzacja, rozwiązywanie problemów (R vs H), eksperymenty IU, ekspozycja pisemna, profilaktyka nawrotów.

Dla kogo: pacjent *analityczny*, lubi struktury, kwestionariusze, dziennik.

MCT (WELLS)

8–12 sesji · model CAS

Centrum: metaprzekonania o martwieniu (pozytywne + negatywne) + CAS.

Narzędzia: psychoedukacja modelu, trening uwagi ATT, oderwana uważność (DM), eksperymenty na metaprzekonania, odroczenie martwienia.

Dla kogo: pacjent *uwagowy*, ma silne metaprzekonania, „nie kontroluję myśli”.

ACT (ROEMER & ORSILLO)

12–16 sesji · sztywność psychiczna

Centrum: elastyczność psychologiczna · akceptacja + wartości + zaangażowane działanie.

Narzędzia: defuzja, akceptacja, kontakt z chwilą obecną, „ja” jako kontekst, wartości, zaangażowane działanie, metafory.

Dla kogo: pacjent *egzystencjalny*, szuka sensu, „muszę zaakceptować” działa lepiej niż „muszę zmienić”.

02 ☉ Trzy fazy wspólne dla wszystkich protokołów

FAZA 1 · SESJE 1–4

Diagnoza + psychoedukacja + baseline.

Wywiad, GAD-7, PSWQ, IUS-12. Psychoedukacja modelu. 2-tygodniowy dziennik samomonitorowania. Mapa martwienia.

FAZA 2 · SESJE 5–12

Praca z mechanizmem.

Tu różnice między protokołami: CBT — restrukturyzacja + R/H + ekspozycja; MCT — ATT + DM + eksperymenty meta; ACT — defuzja + wartości + działanie.

FAZA 3 · SESJE 13–16

Profilaktyka nawrotów + integracja.

Plan profilaktyki, sygnały ostrzegawcze, „terapeuta wewnętrzny”, sesje przypominające co 1–3 mies. przez rok po zakończeniu.

KTÓRY PROTOKÓŁ WYBIERAM?

— CBT klasyczne / MCT / ACT

Z KIM PRACUJĘ?

— psychoterapeuta / psychiatra / lekarz POZ

DLACZEGO TEN?**KIEDY PIERWSZA SESJA?****MOJE CELE TERAPII (3 MIERZALNE)**

— np. „GAD-7 spadek z 16 do < 10”, „sen 7 h”, „powrót do biegania”

1. Czy pracujesz wg **konkretnego protokołu** dla GAD? Jakiego?
2. Ile **sesji** typowo wymaga ten protokół?
3. Jakimi **narzędziami pomiarowymi** będziesz monitorować postęp?
4. Co mam **robić między sesjami** (zadania, dziennik)?
5. Co zrobisz, jeśli po **6-8 sesjach** brak poprawy?
6. Czy **współpracujesz z psychiatrą**, jeśli leki będą potrzebne?
7. Jaka jest twoja **strategia kończenia** terapii?
8. Czy mogę **zadawać pytania** między sesjami (mail, wiadomość)?

Pamiętaj: wybór protokołu *nie jest na zawsze*. Jeśli po 6-8 sesjach widzisz, że dany nurt Ci nie służy — możesz zmienić. Dobra terapia GAD jest **elastyczna**: dobry terapeuta dostosowuje narzędzia do potrzeb, nie odwrotnie. Skuteczność wszystkich trzech nurtów jest *porównywalna* — wybór to kwestia dopasowania, nie „lepszego” wyboru. Najważniejsze: **relacja** z terapeutą — jakość przymierza terapeutycznego jest najsilniejszym predyktorem efektu (Wampold, 2015).